

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0316

Paginas del documento: 12

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

La Odontopediatría en las redes sociales: un análisis a la luz del Código de Ética Odontológica

Resumen: Considerando que el uso creciente de las redes sociales está asociado con el irrespeto a los preceptos éticos establecidos por el Código de Ética Odontológica, este artículo tiene como objetivo analizar e identificar infracciones éticas cometidas por perfiles de odontopediatría en Instagram. Se realizó un estudio exploratorio transversal, en el cual se buscaron, durante aproximadamente tres meses, perfiles de odontopediatría en esta red social. Posteriormente, las cuentas fueron analizadas individualmente, los datos fueron recolectados y evaluados de forma descriptiva, considerando publicaciones realizadas durante un período de dos años. Para evaluar si hubo o no infracción ética, se investigó la ocurrencia de los ítems listados en el Art. 44 del Código de Ética Odontológica aprobado por la resolución CFO-118/2012 (CEO/2012). De los 129 perfiles analizados, la mayoría cometió al menos una infracción ética. De las 24.563 publicaciones relacionadas con la odontología, en 6.551 (26,7%) se encontraron características que podrían interpretarse como inadecuaciones éticas según los incisos analizados, siendo la mayoría (25,3%) consideradas infracciones éticas. Se concluye que la mayoría de los perfiles de odontopediatría encontrados en Instagram están en desacuerdo con los preceptos éticos establecidos por el Código de Ética Odontológica, siendo que las infracciones más comunes están relacionadas con la divulgación de la imagen de los pacientes.

Palabras clave: ética odontológica; odontopediatría; red social; códigos de ética; bioética

Pediatric Dentistry on Social Media: An Analysis in Light of the Code of Dental Ethics

Abstract: Considering that the growing use of social media is associated with the disregard of the ethical precepts established by the Code of Dental Ethics, this article aims to analyze and identify ethical violations committed by pediatric dentistry profiles on Instagram. A cross-sectional exploratory study was conducted, in which pediatric dentistry profiles on this social network were searched for over approximately three months. Subsequently, the accounts were individually analyzed, and data were collected and evaluated descriptively, considering posts made over a two-year period. To determine whether there was an ethical violation, the occurrence of the items listed in Article 44 of the Code of Dental Ethics approved by CFO Resolution No. 118/2012 (CDE/2012) was investigated. Of the 129 profiles analyzed, the majority committed at least one ethical violation. Out of 24,563 dentistry-related posts, 6,551 (26.7%) contained characteristics that could be interpreted as ethical breaches according to the analyzed provisions, with most of them (25.3%) considered ethical violations. It is concluded that most of the pediatric dentistry profiles found on Instagram are not in compliance with the ethical precepts established by the Code of Dental Ethics, with the most common violations related to the disclosure of patients' images.

Keywords: Dental Ethics; Pediatric Dentistry; Social Media; Codes of Ethics; Bioethics

deral de Odontologia (CFO) (1). encontra-se nos grandes centros o que acarreta um mercado de trabalho extremamente competitivo. Sabe-se que o cirurgião-dentista que dota apenas de conhecimento técnico e científico e carece de estratégias de marketing para atrair e conquistar o paciente, não possui garantia alguma de sucesso profissional (1, 2, 3).

Nos últimos anos, com a popularização das redes sociais, houve uma significativa ampliação na busca online por conteúdos referentes à saúde (4). Estudos descreveram que em torno de 75% a 90% dos pais pesquisam informações de saúde referentes aos seus filhos através dos diversos meios oferecidos online. Sendo o objetivo desses, na maioria das vezes, compreender sintomas e determinar se há necessidade de busca por ajuda profissional (5, 6, 7).

O Código de Ética Odontológica (CEO) aprovado pela resolução CFO-118/2012 (CEO/2012) estabelece preceitos para a comunicação e a divulgação em Odontologia e determina quais atitudes caracterizam uma má conduta do cirurgião dentista, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia. O documento determina ainda que a publicidade e propaganda podem ser feitas através de qualquer meio de comunicação, desde que sejam respeitados os preceitos determinados pelo CEO/2012 (8).

Contudo, nem todo o conteúdo presente nas redes sociais se faz adequado em um contexto profissional. Estudos descreveram com propriedade as infrações éticas cometidas por perfis de Odontologia no *Facebook* e *Instagram*, demonstrando que o crescente uso das redes sociais está associado ao desrespeito de preceitos éticos estabelecidos pelo Código Ético de Odontologia (9, 10).

Entre as infrações cometidas, sabe-se ainda que a exposição do paciente tem ganhado notoriedade, sendo a Odontopediatria descrita como a especialidade que mais expôs pacientes em perfis

Diante desse cenário, o objetivo deste estudo foi identificar e quantificar infrações éticas cometidas por perfis brasileiros de Odontopediatria na rede social *Instagram*. Buscou-se analisar, ainda, os temas envolvidos nas postagens, suas características e teor, bem como descrever as características demográficas dos administradores dos perfis.

Metodologia

Trata-se de um estudo exploratório transversal cujo material analisado consiste em páginas de Odontopediatria na rede social *Instagram*. A busca foi realizada por um único pesquisador no período entre 26/10/2021 e 10/01/2022, através das ferramentas de pesquisa oferecidas pela própria rede social, utilizando os termos “odontopediatria”, “odontopediatra”, “dentista para criança”, “dentista de criança”. Dentre os filtros disponibilizados pelo mecanismo de busca do *Instagram* foi utilizado o filtro “contas”.

Os critérios de inclusão foram: contas/páginas que abordam temas relacionados à Odontopediatria, sejam elas pertencentes a clínicas odontológicas ou a cirurgiões-dentistas, especializados ou não em Odontopediatria, ligados ou não a instituições de ensino. Os critérios de exclusão foram: contas privadas que disponibilizam os dados e postagens apenas aos seguidores; contas estrangeiras, por seus responsáveis não serem reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia; contas que sofreram alterações no nome, impossibilitando sua identificação ao longo da pesquisa; perfis que não contêm postagens datadas dentro do período analisado; e perfis que não têm como objetivo a interação com o público, como perfis de liga acadêmica, que tem como foco se comunicar com estudantes de Odontologia.

Em um primeiro momento foram listados todos os perfis encontrados. Posteriormente, foram aplicados os critérios de exclusão, e efetuada a coleta dos seguintes dados nas contas selecionadas:

- crição no Conselho Regional de RO);
- d) especialidades, reconhecidas pelo CRO, citadas pelo responsável pelo perfil;
- e) títulos de formação acadêmica ‘stricto sensu’ e do magistério relativos à profissão.
- f) Cada conta/página teve as postagens analisadas
- h) enquadramento ético (se houver).
- Para avaliar se houve ou não infração ética, foi explorada a ocorrência nas postagens datadas dentro do período de 31 de março de 2020 a 31 de março de 2022, dos seguintes itens listados no Art.44 do Código de Ética Odontológica aprovado pela resolução CFO-118/2012 (CEO/2012), descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Itens listados no Art. 44 do Código de Ética Odontológica aprovado pela resolução CFO - 118/2012.

Inciso	Descrição
I	Fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens de antes e depois, com preços, serviços gratuitos, modalidades de pagamento ou outras formas que impliquem comercialização da Odontologia ou contrariem o disposto no Código.
III	Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento ou áreas de atuação que não estejam devidamente comprovadas cientificamente, assim como instalações e equipamentos sem registro validado pelos órgãos competentes.
IV	Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou ultrapassadas.
VI	Divulgar nome, endereço ou qualquer outro elemento que identifique o paciente sem seu consentimento livre e esclarecido (ou de seu responsável legal), salvo quando não houver finalidade de autopromoção ou benefício do profissional, respeitando as previsões do Código.
VII	Aliciar pacientes por meio de informações ou anúncios falsos, irregulares, ilícitos ou imorais, visando atrair clientela ou praticar atos que configurem concorrência desleal, especialmente com o uso da expressão “popular”.
VIII	Induzir a opinião pública a acreditar que existe reserva de atuação clínica em Odontologia.
IX	Oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção ou promover campanhas oferecendo trocas de favores.
X	Anunciar serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza ou através da aquisição de bens pela utilização dos serviços prestados.
XI	Promover, direta ou indiretamente, por meio de publicidade ou propaganda, a poluição do ambiente.
XII	Expor ao público leigo artifícios de propaganda com o intuito de granjear clientela, especialmente com o uso de imagens e/ou expressões de antes, durante e depois de procedimentos odontológicos.
XIII	Participar de programas de comercialização coletiva oferecendo serviços em veículos de comunicação.
XIV	Divulgar e oferecer serviços odontológicos com finalidade mercantil e de aliciamento de pacientes, por meio de cartão de descontos, mala direta via internet, sites promocionais ou de compras coletivas, telemarketing ativo, stands promocionais, caixas de som, plaqueteiros ou outros meios que caracterizem concorrência desleal e desvalorização da profissão.

Fonte: elaborada pelos autores.

Devido ao acesso restrito a alguns dados e com o objetivo de simplificar o estudo, não foram avaliados os incisos II (Anunciar ou divulgar títulos, qualificações, especialidades que não possua, sem registro no Conselho Federal, ou que não sejam por ele reconhecidas) e V (Dar consulta, diagnóstico,

prescrição de tratamento ou divulgar resultados clínicos por meio de qualquer veículo de comunicação de massa, bem como permitir que sua participação na divulgação de assuntos odontológicos deixe de ter caráter exclusivo de esclarecimento e educação da coletividade) (8).

ontrados na pesquisa inicial, 58 ídos da análise. Dos perfis excluídos, 18 perfis não foram encontrados para a avaliação das postagens, 13 perfis não possuíam o objetivo de interação com o público (ligas acadêmicas, cursos, entidades e instituições), 12 perfis eram contas repetidas, 6 perfis não continham postagens dentro do período avaliado, 6 eram contas privadas que não permitiam o acesso das publicações e 3 perfis eram internacionais. Desse

a realização de pós-graduação *lato sensu* foi descrita em 104 perfis e a pós-graduação *stricto sensu* foi descrita em 24 perfis. A Tabela 3 descreve as especializações e os títulos informados.

A maioria dos perfis analisados cometeram ao menos uma infração ética. A Tabela 4 descreve a prevalência das infrações éticas cometidas por perfis. Destacam-se os incisos VI, XII, I, VIII, III e VII como as infrações mais encontradas, respectivamente.

Tabela 2. Dados demográficos dos 129 perfis analisados.

Dados demográficos (Total=129)		N	(%)
Região	Não informado	18	(14,0%)
	Centro-Oeste	11	(14,0%)
	Nordeste	18	(14,0%)
	Norte	4	(3,1%)
	Sudeste	34	(26,4%)
	Sul	44	(34,1%)
Número do CRO informado	Não	40	(62,0%)
	Sim	49	(39,0%)
Número de pós-graduações <i>lato sensu</i>	0	25	(19,4%)
	1	82	(63,6%)
	2	20	(15,5%)
	3	1	(0,8%)
	4	1	(0,8%)
	0	105	(81,4%)
Número de pós-graduações <i>stricto sensu</i>	1	9	(7,0%)
	2	13	(10,1%)
	3	2	(1,6%)

Fonte: Elaborada pelos autores.

<i>nsu</i>	Implantodontia	1	(0,8%)
	Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais	6	(4,6%)
	Odontopediatria	101	(78,3%)
	Ortodontia	14	(10,9%)
	Ortopedia Funcional dos Maxilares	4	(3,1%)
Especializações <i>stricto sensu</i>	Mestrado	23	(17,8%)
	Doutorado	15	(11,6%)
	Pós-doutorado	3	(2,3%)

Fonte: Elaborada pelos autores.

Tabela 4. Distribuição das infrações éticas por perfis analisados.

Perfis analisados (Total=129)	N	(%)
Infração ao inciso I	20	(15,5%)
Infração ao inciso III	5	(3,9%)
Infração ao inciso IV	0	(0,8%)
Infração ao inciso VI	121	(93,8%)
Infração ao inciso VII	4	(3,1%)
Infração ao inciso VIII	9	(7,0%)
Infração ao inciso IX	0	(0,0%)
Infração ao inciso X	0	(0,0%)
Infração ao inciso XI	0	(0,0%)
Infração ao inciso XII	74	(57,4%)
Infração ao inciso XIII	0	(0,0%)

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para compreender a diversidade de infrações éticas entre os perfis analisados, foi avaliado, em cada caso, quantos tipos diferentes de infração ao Código de Ética Odontológica foram cometidos. Com base nessa análise, os 129 perfis foram classificados em cinco grupos, de acordo com a quantidade de tipos distintos de infração identificados. A maior parte dos perfis cometeu um (32,56%) ou

dois (44,96%) tipos de infração, totalizando mais de 77% da amostra. Um número menor de perfis cometeu três tipos (13,95%) ou quatro ou mais tipos de infração (3,88%). Apenas 6 perfis (4,65%) não apresentaram nenhuma infração ética identificável nas postagens avaliadas. A Tabela 5 descreve a distribuição dos perfis segundo o número de tipos distintos de infração ética cometidos.

	42	(32,56%)
	58	(44,96%)
3	18	(13,95%)
4 ou mais	5	(3,88%)

Fonte: Elaborada pelos autores.

Discussão

Este estudo evidencia que uma considerável parcela dos cirurgiões dentistas negligencia o cumprimento do Art.44 do Código de Ética Odontológica, conforme estabelecido pela Resolução CFO-118/2012, uma vez que a maioria dos perfis analisados cometeu pelo menos uma infração.

Em nossa análise, constatamos que a divulgação do número de registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) apresentou índices superiores aos resultados obtidos por Lima et al. e por Soares et al., nos quais apenas 5,71% e 24%, respectivamente, dos perfis do *Instagram* informavam o registro (11, 12). No entanto, nossos resultados ficaram aquém dos encontrados por Penteado et al., onde 64,6% dos perfis do *Instagram* continham essa informação (10).

Em relação aos incisos do artigo 44 analisados, observou-se que grande parte dos perfis cometeu ao menos uma infração e a maioria delas envolveu a divulgação da imagem dos pacientes ou qualquer outro elemento que identifique o paciente sem o devido consentimento (inciso VI). Essa tendência está alinhada a estudos regionais e nacionais que descreveram a Odontopediatria como a especialidade que mais compartilha fotos de pacientes (9). As publicações consideradas inadequadas envolviam, em sua maioria, exposição do paciente ao lado do profissional, imagens durante o atendimento e das atividades lúdicas realizadas durante a consulta; características diferentes do estudo brasileiro de Martorell et al., no qual 44,8% das imagens encontradas no *Instagram* estavam relacionadas ao transoperatório (13).

Ainda no que diz respeito à divulgação de imagens de pacientes, Lee et al. conduziram um estudo que tinha como objetivo principal determinar como a saúde bucal de crianças pequenas é promovida e apoiada no *Instagram*. Mediante a análise de 1.071 imagens, eles constataram que 57,5% eram imagens de pessoas, sendo que destas, 79,7% também eram crianças (14).

O número total de publicações que envolviam o artifício de imagens de “antes e depois” (inciso XII e inciso I) também apresentou divergência em relação ao estudo de Martorell et al., no qual 21,1% das imagens seguiram este formato (13). Entretanto, ao analisar os perfis que continham publicações de “antes e depois” encontraram-se valores semelhantes ao estudo de Lima et al., no qual 46,3% dos perfis do *Facebook* e *Instagram* publicaram imagens de “antes e depois” (11). Esses resultados também se assemelharam ao estudo de Penteado et al., no qual 72,9% dos perfis do *Instagram* continham imagens com características de “resultados finais” (10). Esse padrão demonstra que, embora não seja a principal ferramenta utilizada na Odontopediatria, ainda sim o “antes e depois” é utilizada como estratégia publicitária por esse público.

As divergências identificadas podem ser atribuídas, em parte, ao direcionamento publicitário adotado por esses profissionais. Os perfis dedicados ao atendimento de crianças concentram-se principalmente na persuasão dos responsáveis no que diz respeito ao “cuidado do paciente”, ao contrário dos profissionais especializados em Ortodontia, Implantodontia e Periodontia, que constituíram as populações mais prevalentes no estudo anterior de Martorell et al. e focam seus esforços

mento na exposição de pacientes e publicações de conteúdos extivo está associado a decisões do CFO, em especial à Resolução 196/2019, que autoriza a divulgação de autoretratos (selfies) e de imagens relativa ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos. Essa resolução é considerada por alguns autores como uma autorização para a divulgação de imagens de pacientes (9, 10). Porém, é importante ressaltar que ela também traz um alerta subsequente, ressaltando que esse formato de publicação não está liberado de maneira indiscriminada e orienta sobre os cuidados que devem ser tomados. Além disso, a resolução fornece informações adicionais sobre outras precauções a serem consideradas em relação a publicações nas redes sociais (15).

Embora as decisões do CFO sejam relevantes, é crucial ressaltar que alguns estudos salientam que tais medidas não excluem a necessidade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No entanto, Bahabri e Zaidan demonstraram que 86% dos entrevistados em sua pesquisa publicaram fotografias de pacientes sem obter o consentimento informado, seja verbal ou escrito (16). Esses estudos alertam para a maior complexidade no contexto do atendimento odontológico infantil, especialmente quando consideramos as implicações legais delineadas por outras instâncias jurídicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069/1990) (9). O Artigo 17 do ECA estabelece de maneira clara a garantia dos direitos da criança ao respeito, preservação de sua imagem e identidade, autonomia, valores e crenças. O inciso V do Artigo 100 do ECA estabelece o direito à privacidade, destacando que a promoção dos direitos e a proteção da criança devem ser realizadas com respeito à sua intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada.

Conforme previsto nos princípios do ECA, é fundamental que o respeito à imagem e à privacidade da criança leve em conta sua condição de pessoa em desenvolvimento. À medida que a

progressiva e assegurar que essa exposição não contrarie seus sentimentos ou vontade. Essas exposições configuram situações delicadas no contexto odontológico, reforçando a necessidade de garantir a integridade e privacidade das crianças durante o atendimento, especialmente quando se trata da divulgação de suas imagens (17).

Outra infração que merece destaque está relacionada ao inciso VIII (“induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva de atuação clínica em Odontologia”). Em nosso estudo, observamos que essa infração foi inferior aos 36,8% identificados em um estudo nacional com 384 perfis do *Instagram* (10). No entanto, nenhuma explicação foi encontrada para essa divergência.

O uso das redes sociais com propósitos profissionais está ganhando cada vez mais força. De fato, quando utilizada de maneira estratégica, pode exercer um impacto significativo na divulgação do trabalho do odontopediatra, trazendo-lhe inúmeros benefícios, como reconhecimento e maior número de pacientes. Além disso, elas são vantajosas para o público em geral, pois funcionam tanto como uma ferramenta que auxilia na busca e seleção de profissionais da saúde (18), quanto como um recurso educacional, oferecendo dicas, informações e respondendo a dúvidas (19, 20), visto que os usuários buscam frequentemente por conteúdo relacionado à saúde bucal na primeira infância (14).

Embora alguns perfis possam veicular conteúdo inadequado, muitos oferecem informações valiosas que contribuem para a educação do público em geral. O estudo conduzido por Lee et al. oferece percepções pertinentes nesse sentido. Eles concluíram que as informações relacionadas à saúde bucal da criança divulgadas na rede social *Instagram* têm o potencial de gerar uma sensibilização mais ampla sobre a saúde bucal, fornecendo orientação antecipada e apoio motivacional para a adoção de comportamentos preventivos contra a cárie precoce da infância. Essa descoberta é importante, pois ressalta o papel significativo que as redes sociais

es de saúde falsas ou enganosas são estimuladas por opiniões autônomas dos usuários digitais (21, 22). Essa dinâmica pode levar ao desenvolvimento de crenças prejudiciais sobre a saúde e acarretar consequências adversas para a qualidade de vida da população (23, 24). Segundo estudos recentes, cerca de 80% dos usuários depositam confiança na autenticidade das informações online, o que contribui para o compartilhamento mais frequente de conteúdo enganoso do que confiável nas redes sociais (25, 26, 27). Um estudo conduzido por Loto *et al.* teve como objetivo identificar e caracterizar a disseminação de desinformação nas redes sociais sobre saúde bucal. Eles concluíram que a maioria das informações falsas encontradas estava vinculada a profissionais da Odontologia e visava interesses financeiros, sociais e/ou psicológicos (28). Essa forma de desinformação, com um claro viés enganoso e comercial, pode estar em desacordo com o inciso I do Código de Ética Odontológica, o qual foi o terceiro mais frequentemente violado pelos perfis analisados em nosso estudo.

A preocupação com a desinformação nas redes sociais não se restringe à Odontopediatria. Diversos estudos em outras áreas da saúde também abordam tal situação. Para Oregi *et al.*, considerando que as plataformas digitais estão em constante expansão, é importante que bons profissionais, nesse caso, os cirurgiões-plásticos, estejam presentes para disseminar informações verdadeiras e combater as falsas. Dessa forma, os pacientes terão acesso também a fontes confiáveis, além de possibilidade de comparação entre os perfis e, consequentemente, escolhas mais seguras (29).

Portanto, embora o uso das redes sociais possa trazer oportunidades tanto para os odontopediatras quanto para a população em geral, é importante reconhecer os potenciais riscos envolvidos. Para promover o uso adequado das tecnologias e minimizar os riscos associados, diversos estudos defendem a necessidade de estabelecer políticas e diretrizes

diretriz para fazer o uso das redes sociais para fins profissionais (34). Nesse contexto, alguns autores também sugerem que a educação acerca do uso profissional dessas mídias seja incorporada ao currículo de Odontologia (30, 31). Essas iniciativas são fundamentais para garantir que as redes sociais sejam utilizadas de maneira ética e responsável por parte dos cirurgiões dentistas, promovendo benefícios para toda a comunidade.

Esse estudo foi o primeiro a realizar uma análise ética de perfis voltados para o atendimento odontológico infantil. É importante destacar algumas limitações dessa pesquisa, como o funcionamento do mecanismo de busca fornecido pela rede social *Instagram*, que pode ser influenciado pelo perfil do usuário que o acessa. Além disso, as informações profissionais fornecidas nos perfis foram consideradas verídicas sem a devida verificação junto às entidades da classe. Para futuros estudos, sugere-se a confirmação dos dados informados por meio de órgãos oficiais, em especial o registro nos Conselhos Regionais de Odontologia.

Conclusão

Concluiu-se então que a maioria dos perfis de Odontopediatria encontrados no *Instagram* está em desacordo com os preceitos éticos estabelecidos pelo Código de Ética Odontológica, sendo que as infrações éticas mais cometidas estão relacionadas à divulgação da imagem de pacientes infantis. Esta constatação suscita preocupações significativas sobre a responsabilidade profissional e o cuidado ético nas redes sociais. Além disso, a exposição não autorizada de imagens de crianças pode acarretar em consequências negativas, como a violação de direitos legais e o risco de causar danos emocionais para o paciente e à sua família. Portanto, é fundamental que os profissionais odontopediatras estejam cientes das implicações éticas de suas ações nas redes sociais e ajam de acordo com o padrão de ética profissional para garantir a integridade e o bem-estar dos seus pacientes.

